

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE SEPSE

Bundle da 1ª Hora • Diagnóstico • Estratificação • Tratamento • Metas

■ Baseado em: Surviving Sepsis Campaign 2021 • Sepsis-3 (JAMA 2016) • AMIB 2023

1. DEFINIÇÕES — SEPSIS-3 (2016)

Síndrome	Definição	Critério Prático
SIRS	Resposta inflamatória sistêmica (NÃO é sepse)	2 ou mais: Temp >38 ou <36°C, FC >90, FR >20, Leuco >12k ou <4k
SEPSE	Disfunção orgânica ameaçadora à vida por infecção	SOFA ≥ 2 pontos + suspeita de infecção
Choque Séptico	Sepse + hipotensão refratária + hiperlactatemia	PAM < 65 mmHg após vol + Lactato > 2 mmol/L + vasopressor

qSOFA — Triagem Rápida (beira do leito)

Critério	Ponto
FR ≥ 22 irpm	1
Alteração do nível de consciência (Glasgow < 15)	1
PAS ≤ 100 mmHg	1

■ qSOFA ≥ 2 = Alto risco de disfunção orgânica → Calcular SOFA completo e acionar protocolo de sepse imediatamente

Escala SOFA — Quantificação de Disfunção Orgânica

Sistema	SOFA 1	SOFA 2	SOFA 3	SOFA 4
Respiratório (PaO2/FiO2)	< 400	< 300	< 200 + VM	< 100 + VM
Coagulação (Plaquetas ×10³)	< 150	< 100	< 50	< 20
Hepático (Bilirrubina mg/dL)	1,2–1,9	2,0–5,9	6,0–11,9	≥ 12,0
Cardiovascular (PAM/Vasopressor)	PAM < 70	Dopa ≤ 5	Dopa > 5 ou Nora ≤ 0,1	Dopa > 15 ou Nora > 0,1

Sistema	SOFA 1	SOFA 2	SOFA 3	SOFA 4
Neurológico (Glasgow)	13–14	10–12	6–9	< 6
Renal (Creatinina mg/dL)	1,2–1,9	2,0–3,4	3,5–4,9 ou DU < 500mL/d	≥ 5,0 ou DU < 200mL/d

■ *SOFA ≥ 2: suspeita de sepse. SOFA basal = 0 em pacientes sem disfunção prévia. Aumento ≥ 2 pontos = disfunção orgânica aguda.*

2. BUNDLE DA 1ª HORA — SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN 2021**■ TEMPO É VIDA: Mortalidade aumenta ~7% a cada hora de atraso no antibiótico em choque séptico**

#	Ação	Tempo-Alvo	Detalhe
1	Colher LACTATO sérico	≤ 30 min	Lactato > 2 mmol/L sugere hipoperfusão. Se > 4: recolher em 2h para avaliar clareamento
2	Colher HEMOCULTURAS (2 pares)	≤ 30 min	Antes do ATB se possível. 2 sítios diferentes. Não atrasar ATB > 45 min por causa das culturas
3	Iniciar ANTIBIÓTICOS de amplo espectro	≤ 60 min (choque) ≤ 3h (sepsis sem choque)	Escolha baseada em foco provável, flora local e fatores de risco para MRSA/MR-GN
4	Cristaloide EV se hipotensão ou lactato ≥ 4	≤ 30 min	SF 0,9% ou Ringer Lactato 30 mL/kg em 3h. Reavaliar com parâmetros dinâmicos (VPP, VVS, PPP) após cada 500 mL
5	Vasopressor se PAM < 65 mmHg	Simultâneo à vol	Noradrenalina 1ª escolha. Manter PAM ≥ 65 mmHg. Acesso venoso central quando possível

Escolha Empírica de Antibióticos por Foco

Foco Suspeito	Antibiótico de 1ª Escolha	Dose
Pulmonar (PAC grave)	Ampicilina/Sulbactam + Azitromicina ou Levofloxacino + Beta-lactâmico	Ampi/Sul 3g EV 6/6h Levo 500 mg EV 1x/dia
Pulmonar (PAH/PAVM)	Pip/Tazo + Vancomicina (se risco MRSA)	Pip/Tazo 4,5g EV 6/6h Vancomicina 25 mg/kg ataque
Abdominal/GI	Pip/Tazo ou Cefotaxima + Metronidazol	Pip/Tazo 4,5g EV 6/6h Cefto 2g EV 8/8h + Metro 500mg 8/8h
Urinar (urosepsis)	Ceftriaxona ou Cefepima (risco ESBL)	Ceftriaxona 2g EV 1x/dia Cefepima 2g EV 12/12h
Pele/Partes moles	Oxacilina (sem MRSA) ou Vancomicina (MRSA)	Oxacilina 2g EV 6/6h Vancomicina 25 mg/kg ataque
Foco desconhecido	Pip/Tazo + Vancomicina	Pip/Tazo 4,5g EV 6/6h Vancomicina 25 mg/kg ataque
Neutropenia febril	Cefepima ou Pip/Tazo + Vancomicina se inst. hemodin.	Cefepima 2g EV 8/8h

■ DEESCALONAMENTO: Reavaliar cobertura em 48–72h com resultado das culturas. Estreitar espectro sempre que possível!

3. RESSUSCITAÇÃO VOLÊMICA — PROTOCOLO

Fase	Objetivo	Conduta
Ressuscitação (0–6h)	Reverter hipoperfusão aguda	30 mL/kg de cristalóide em 3h. Reavaliar após cada 250–500 mL com parâmetros dinâmicos
Otimização (6–24h)	Atingir metas hemodinâmicas	Guiar por: PAM, diurese, lactato, VPP/VVS (se VM). Evitar excesso hídrico
Estabilização (24–72h)	Manter perfusão sem sobrecarga	Cristalóide criterioso. Iniciar diurético se balanço positivo >3L sem resposta
Descongestionamento (>72h)	Remover fluido acumulado	Furosemida EV 1–2 mg/kg. Meta: balanço negativo 1–1,5 L/dia

Parâmetros de Resposta à Volemia

Parâmetro	Valor / Método	Interpretação
VPP — Variação de Pressão de Pulso	> 13% = responsivo	Só válido em VM volume controlado, sem arritm., FR/VC adequado
Teste de Elevação Passiva das Pernas	Aumento DC > 10% em 1 min	Reversível, válido em resp. espontânea e VM
Mini-Fluid Challenge	Bolus 100 mL em 1 min → mede DC	Menos risco de sobrecarga
Lactato (clareamento)	Redução ≥ 10% em 2h	Melhor do que valor absoluto para guiar ressuscitação
Diurese	≥ 0,5 mL/kg/h	Marcador simples de perfusão renal
Ultrassom (VCI)	Colapsabilidade > 50% em resp. esp.	Sugere hipovolemia; limitações em obesos e DPOC

4. METAS TERAPÊUTICAS — CHOQUE SÉPTICO

Parâmetro	Meta	Observação
PAM	≥ 65 mmHg	Pode ser 80–85 em hipertenso crônico severo
Lactato	< 2 mmol/L (clareamento ≥ 10%/2h)	Monitorar de 2/2h até normalização
Diurese	≥ 0,5 mL/kg/h	Não forçar diurese com furosemida na fase aguda
ScvO ₂ (cateter central)	≥ 70%	Indicador de equilíbrio oferta/consumo de O ₂
Hematócrito	> 30% (Hb > 7–8 g/dL)	Transfundir se Hb < 7 g/dL (< 9 se isquemia ativa)
Glicemia	140–180 mg/dL	Evitar hipoglicemia (<70). Insulinoterapia alvo 140–180
Temperatura	Controle febril ≥ 39,5°C	Antitérmico se febre alta comprometendo débito
Plaquetas	> 20.000 (transfundir) > 50.000 (procedimento)	Avaliar CID associada

Vasopressores — Protocolo de Uso

Droga	Dose inicial	Dose máx.	Indicação / Observação
Noradrenalina (1ª linha)	0,01–0,05 mcg/kg/min	3 mcg/kg/min	Acesso central preferido. Monitorar PAI se possível
Vasopressina (adjuvante)	0,03 UI/min fixo	0,04 UI/min	Adicionar se Nora > 0,25 para poupar dose
Dopamina (2ª linha)	5–20 mcg/kg/min	20 mcg/kg/min	Só se bradiaritm. associada. Maior risco de arr.
Adrenalina (refratário)	0,01–0,5 mcg/kg/min	1 mcg/kg/min	Choque refratário ou parada cardíaca

✓ Corticoterapia: Hidrocortisona 200 mg/dia EV (50mg 6/6h ou 200mg infusão contínua) se Nora $\geq$ 0,25 mcg/kg/min por $\geq$ 4h

5. CHECKLIST DO BUNDLE — USO BEIRA DO LEITO

■ Preencher na admissão de todo paciente com suspeita de sepse. Registrar horário de cada etapa no prontuário.

■	Horário do reconhecimento da sepse: ____:____
■	qSOFA calculado: ____ / 3 • SOFA calculado: ____ / 24
■	Coleta de LACTATO sérico (horário: ____:____) → Resultado: ____ mmol/L
■	HEMOCULTURAS coletadas — 2 pares, 2 sítios (horário: ____:____)
■	ATB iniciado (horário: ____:____) — Droga: _____ Dose: _____
■	Acesso venoso calibroso obtido (periférico ≥ 18G ou central)
■	Volume SF 0,9% ou RL 30 mL/kg iniciado — Volume total: ____ mL — Horário início: ____:____
■	PAM verificada após volume: ____ mmHg • Meta ≥ 65 mmHg atingida? SIM / NÃO
■	Noradrenalina iniciada se PAM < 65 após volume (horário: ____:____) — Dose inicial: ____ mcg/kg/min
■	Lactato de controle (2h após): ____ mmol/L • Clareamento ≥ 10%? SIM / NÃO
■	Fisioterapia acionada para ventilação e mobilização
■	Foco infeccioso identificado / controlado (drenagem, retirada de cateter etc.)
■	Reavaliação de ATB em 48–72h agendada — Data: ____/____/____
■	Família informada: diagnóstico, prognóstico e plano

Médico responsável: _____ CRM: _____ Data: ____/____/____ Hora início protocolo: ____:____

Referências: Singer M et al. Sepsis-3. JAMA 2016; Evans L et al. SSC Guidelines. Intensive Care Med 2021; AMIB – Protocolo Brasileiro de Sepsis 2023.

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE CONTROLE GLICÊMICO HOSPITALAR

Escala de Insulina • CAD • EHH • Hipoglicemia • Metas

■ Baseado em: ADA Standards of Medical Care 2024 • AACE/ACE Inpatient Glycemia Consensus 2022 • SBD 2023

1. METAS GLICÊMICAS — CONTEXTO HOSPITALAR

Contexto Clínico	Meta Glicêmica	Justificativa
Enfermaria de Clínica Médica	140–180 mg/dL	Reduz morbimortalidade sem risco aumentado de hipoglicemia
UTI — paciente crítico	140–180 mg/dL	NICE-SUGAR trial; controle estrito (<110) aumenta mortalidade
Perioperatório — cirurgia geral	140–180 mg/dL	Manter até retorno a dieta normal
AVC isquêmico agudo	140–180 mg/dL	Hiperglicemia pós-AVC piora prognóstico neurológico
IAM / síndrome coronariana	140–180 mg/dL	Evitar hiper e hipoglicemia no contexto isquêmico
Gravidez (DM gestacional)	60–99 (jejum) < 140 (2h pós)	Protocolo obstétrico específico; avaliar com obstetra
Cuidados paliativos / terminal	Evitar hipo (<70)	Prioridade = conforto; não há benefício em controle estrito

■ **HIPOGLICEMIA HOSPITALAR:** Glicemia < 70 mg/dL = intervenção imediata. < 54 mg/dL = hipoglicemia grave. Registrar no prontuário e investigar causa.

2. ESCALA CORRETIVA DE INSULINA REGULAR — SUBCUTÂNEA

■ **Escala CORRETIVA:** não substitui insulina basal/prandial. Usar como COMPLEMENTO em pacientes que já recebem insulina basal ou naqueles sem indicação de basal ainda.

Glicemia (mg/dL)	Insulina Sensitivo (Fragilizado, Insulinsensível, CR < 30)	Insulina Padrão (Maioria dos pacientes)	Insulina Resistente (Obeso, Corticoide, Dose >80U/dia)
< 70	VER PROTOCOLO DE HIPOGLICEMIA	VER PROTOCOLO DE HIPOGLICEMIA	VER PROTOCOLO DE HIPOGLICEMIA
70–140	Sem insulina	Sem insulina	Sem insulina
141–180	Sem insulina	Sem insulina	2 U SC
181–220	1 U SC	2 U SC	4 U SC
221–260	2 U SC	4 U SC	6 U SC
261–300	3 U SC	6 U SC	8 U SC

Glicemia (mg/dL)	Insulina Sensitivo (Fragilizado, Insulinsensível, CR < 30)	Insulina Padrão (Maioria dos pacientes)	Insulina Resistente (Obeso, Corticoide, Dose >80U/dia)
301–350	4 U SC	8 U SC	10 U SC
351–400	5 U SC	10 U SC	12 U SC
> 400	Avaliar médico + 6 U SC	Avaliar médico + 12 U SC	Avaliar médico + 14 U SC

Frequência de monitoração glicêmica: Antes das refeições + às 22h (4x/dia) para pacientes em dieta oral. 6/6h para pacientes em jejum, SNE ou com instabilidade glicêmica.

3. REGIME BASAL-BOLO — INSULINOTERAPIA PLENA

■ Preferir Basal-Bolo ao invés de escala corretiva isolada em pacientes internados com DM tipo 1 ou DM2 com glicemias > 180 persistentes ou em uso de corticosteroide.

Componente	Insulina	Cálculo Dose Inicial	Horário
BASAL (50% dose total)	Glargina (Lantus) ou Detemir	Dose total diária inicial: 0,3–0,5 U/kg/dia (0,3 em idosos/IR; 0,5 padrão) Metade = basal	21h–22h (1x/dia) ou 12/12h (detemir)
PRANDIAL (50% dividido 3x)	Regular ou Lispro ou Aspart	Restante da dose total ÷ 3 Aplicar com cada refeição	15 min antes das refeições (ou imediatamente se lispro/aspart)
CORRETIVA (adicional)	Regular ou análogo rápido	Conforme escala da Seção 2 (sensível/padrão/resistente)	Junto às doses prandiais ou 6/6h se em jejum

✓ Regra de ajuste: Se glicemia em jejum > 180 por 2 dias consecutivos → aumentar basal em 10–20%. Se hipoglicemia → reduzir basal em 20%.

4. PROTOCOLO DE HIPOGLICEMIA — TRATAMENTO IMEDIATO

Nível	Glicemia	Paciente CONSCIENTE	Paciente SEM consciência/sem VO
Alerta	54–69 mg/dL	15g de carboidrato simples VO (3 sachês de açúcar + 150 mL água ou 200 mL suco de laranja)	Glicose 25–50% EV 20–40 mL ou Glucagon 1 mg SC/IM
Grave	< 54 mg/dL	20–30g carboidrato VO (repetir se não subir em 15 min)	Glicose 50% EV 40–60 mL Glucagon 1 mg SC/IM
Refratária	< 40 mg/dL ou resistente	Acionar médico imediatamente	Glicose 10% EV em infusão contínua Internação em leito monitorizado

Regra dos 15: 15g de carboidrato → aguardar 15 minutos → checar glicemia. Se ainda < 70: repetir. Oferecer lanche proteico após correção.

Investigar causa: excesso de insulina? jejum prolongado? IRA aguda? interação medicamentosa? sepse? insuficiência adrenal?

5. CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD) — PROTOCOLO COMPLETO

Critério	Leve	Moderada	Grave
Glicemia	> 250 mg/dL	> 250 mg/dL	> 250 mg/dL
pH arterial	7,25–7,30	7,00–7,24	< 7,00
Bicarbonato	15–18 mEq/L	10–14 mEq/L	< 10 mEq/L
Cetonemia/cetonúria	+ leve	++ moderada	+++ intensa
Anion Gap	> 10	> 12	> 12
Nível de consciência	Alerta	Alerta/sonolento	Estupor/coma
Destino	Enfermaria / Obs.	UTI ou SEMI	UTI obrigatória

CAD — Tratamento Passo a Passo

Etapa	Ação	Detalhe / Dose
1 — Hidratação (1ª hora)	SF 0,9% 1000 mL em 1h (15–20 mL/kg)	Depois: SF 0,45% ou 0,9% 250–500 mL/h Trocar para SG 5% quando glicemia < 250 mg/dL
2 — Potássio (ANTES da insulina)	Corrigir hipocalemia ANTES de iniciar insulina	K+ > 3,5: iniciar insulina normalmente K+ 3,0–3,5: repor 20–40 mEq/h + iniciar insulina K+ < 3,0: REPOR K+ SEM INSULINA até K ≥ 3,5
3 — Insulina (após K+)	Insulina Regular EV em infusão contínua	Bolus: 0,1 U/kg EV Infusão: 0,1 U/kg/h Se glicemia não cai ≥ 50 mg/dL/h: dobrar taxa
4 — Glicemia-alvo na fase aguda	Manter 150–200 mg/dL até fechar cetoacidose	NÃO normalizar glicemia antes de fechar CA! Adicionar SG 5% se glicemia < 250
5 — Critérios de fechamento CAD	Glicemia < 200 + pH ≥ 7,30 + Bicarbonato ≥ 15 + AG normal (<12)	Manter insulina EV por 1–2h após 1ª dose SC Iniciar insulina basal-bolo antes de suspender EV
6 — Bicarbonato	Apenas se pH < 6,9 ou instab. hemodinâmica	50–100 mEq em 2h NÃO usar rotineiramente (piora hipocalemia)
7 — Fosfato	Repor se < 1 mg/dL com fraqueza muscular/arritmia	20–30 mEq KH ₂ PO ₄ em 24h

■ **MONITORAR:** Glicemia capilar 1/1h; Eletrólitos + GSV a cada 2–4h nas primeiras 12h; Gap Aniônico = Na - (Cl + HCO₃) — meta < 12

6. ESTADO HIPEROSMOLAR HIPERGLICÊMICO (EHH)

Critério	CAD	EHH
Glicemia	> 250 mg/dL	> 600 mg/dL
pH arterial	< 7,30	> 7,30
Bicarbonato	< 18 mEq/L	> 15 mEq/L
Cetonemia	Positiva	Ausente ou traço
Osmolalidade efetiva	Variável	> 320 mOsm/kg
Déficit de água livre	Moderado	Grave (9–10 L)
Consciência	Geralmente lúcido	Obnubilação / coma comum
Tipo de DM	DM tipo 1 (ou 2)	DM tipo 2 (idosos)

EHH — Tratamento Específico

Etapas	Conduta	Objetivo
Hidratação agressiva	SF 0,9% 1 L/h nas primeiras 2–4h Depois SF 0,45% 250–500 mL/h	Repor 50% do déficit nas primeiras 12h Restante em 24–36h
Insulina	SOMENTE após volemia inicial 0,05 U/kg/h EV (dose menor que na CAD)	Reduzir glicemia 50–75 mg/dL/hora Sem risco de edema cerebral
Potássio	Repor conforme K+ sérico (igual ao protocolo CAD)	Manter K+ 4,0–5,0 mEq/L
Osmolalidade-alvo	Redução máxima 3–8 mOsm/kg/h	Redução rápida = risco de edema cerebral e convulsão
Transição para SC	Glicemia < 300 + paciente alerta + tolerando VO	Iniciar basal-bolo 30 min antes de suspender EV

■ EHH tem mortalidade de 10–20% vs 1–5% da CAD. Principal causa de morte: doença precipitante (infecção, IAM). Tratar causa de base!

Referências: ADA Standards of Medical Care 2024; Kitabchi AE et al. Hyperglycemic Crises in Diabetes. Diabetes Care 2009; AACE/ADA Consensus on Inpatient Glycemic Control 2022.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

CHECKLIST DE ALTA SEGURA

Critérios de Alta • Reconciliação Medicamentosa • Orientações ao Paciente • Continuidade do Cuidado

■ Alta segura reduz reinternação em 30 dias em até 30%. Comunicação eficaz e reconciliação medicamentosa são os pontos mais críticos.

1. CRITÉRIOS MÉDICOS DE ALTA HOSPITALAR

Domínio	Critério para Alta
Hemodinâmica	PA estável sem vasopressor há ≥ 24h; FC e FR dentro de limites aceitáveis
Respiratório	SpO ₂ ≥ 92% em ar ambiente OU em O ₂ suplementar domiciliar já programado
Temperatura	Afebril há ≥ 24h OU febre explicada e em controle com tratamento domiciliar
Via oral / Alimentação	Tolerando dieta oral OU alimentação enteral domiciliar instalada e orientada
Dor	Controlada com analgesia oral OU estratégia domiciliar adequada definida
Infecção / ATB	Em antibioticoterapia oral eficaz OU ciclo IV completado OU alta com ATB oral
Diagnóstico	Diagnóstico principal estabelecido e tratado. Exames relevantes revisados
Suporte social	Cuidador identificado, orientado e disponível. Ambiente domiciliar adequado
Seguimento	Retorno ambulatorial agendado ou encaminhamento definido

■ **CONTRAINDICAÇÕES À ALTA:** instabilidade hemodinâmica, necessidade de O₂ > 4 L/min, febre de causa desconhecida, impossibilidade de via oral sem alternativa domiciliar, ausência total de rede de suporte.

2. RECONCiliaÇÃO MEDICAMENTOSA NA ALTA

■ 70% dos eventos adversos pós-alta são relacionados a medicamentos. A reconciliação reduz erros de omissão, duplicação e doses incorretas.

Passo	Ação	Detalhe
1	Listar medicamentos antes da internação	Nome comercial e genérico, dose, frequência, via. Incluir fitoterápicos, suplementos
2	Comparar com prescrição hospitalar atual	Identificar o que foi suspenso, modificado, substituído ou adicionado
3	Definir o que continua na alta	Cada medicamento deve ter indicação clara. Eliminar duplicatas

Passo	Ação	Detalhe
4	Explicar cada mudança ao paciente	Linguagem simples. Mostrar embalagem se possível. Confirmar compreensão
5	Prescrever em receituário legível	Nome genérico + comercial, dose, via, frequência e duração. Evitar abreviações
6	Atentar para medicamentos de alto risco	Anticoagulantes, insulina, digitálicos, antiarrítmicos, imunossupressores
7	Orientar sobre novos medicamentos	Para que serve, como tomar, efeitos adversos possíveis, o que fazer se falhar

3. ORIENTAÇÕES AO PACIENTE — CONTEÚDO MÍNIMO

Tema	O que Orientar
Diagnóstico	Nome da doença em linguagem simples. O que causou, o que foi feito, o que vem depois
Medicamentos	Lista impressa: nome, dose, horário, para que serve, duração do tratamento
Dieta e hidratação	Restrições alimentares, líquidos permitidos, alimentos a evitar
Atividade física	O que pode e o que não pode fazer. Quando retomar atividades normais
Curativos e feridas	Como fazer em casa, o que é normal, quando buscar ajuda
Sinais de alerta	Sintomas que devem motivar retorno IMEDIATO à emergência
Retorno agendado	Data, local, especialidade e o que levar (exames, receituários, cartão)
Exames pendentes	Culturas, biópsias, outros. Onde retirar o resultado e o que fazer com ele
Vacinação	Verificar cartão e orientar sobre pendências (influenza, pneumococo, COVID)
Contato de emergência	Número do hospital, UPA de referência, orientação sobre SAMU (192)

Sinais de Alerta — Retorno IMEDIATO à Emergência

Situação Clínica	Sintomas de Alarme
Cardiorrespiratório	Falta de ar súbita ou progressiva, dor no peito, palpitações, edema rápido nos pés
Neurológico	Confusão mental, fraqueza súbita em membros, dificuldade de falar, convulsão
Infeccioso / Séptico	Febre > 38,5°C, calafrios, piora do estado geral, hipotensão (tontura ao levantar)
Gastrointestinal	Vômitos incoercíveis, dor abdominal intensa, sangramento (fezes escuras ou vermelhas)
Renal / Urinário	Redução importante do volume urinário, inchaço generalizado súbito
Glicêmico	Tontura, tremores, sudorese fria (hipoglicemia); sede intensa, urina muito frequente (hiperglicemia)
Anticoagulados	Sangramento em qualquer local que não cessa, hematomas extensos, sangue na urina

4. SUMÁRIO DE ALTA — CAMPOS OBRIGATÓRIOS

Campo	Conteúdo Esperado
Identificação	Nome completo, data de nascimento, prontuário, período de internação
Diagnóstico principal e CID	Diagnóstico definitivo ou de trabalho. Diagnósticos secundários ativos
Resumo clínico	Motivo de internação, evolução, intercorrências, procedimentos realizados
Resultados de exames relevantes	Laboratoriais, culturas, imagens, histopatológico — com datas
Medicamentos na alta	Nome genérico, dose, via, frequência, duração de cada medicamento

Campo	Conteúdo Esperado
Pendências	Culturas aguardando, biópsias, exames solicitados e não realizados
Orientações específicas	Curativos, dieta, atividade, dispositivos (oxigênio, ostomias etc.)
Retorno	Especialidade, local, data ou prazo. Critérios para retorno de urgência
Prognóstico	Quando relevante para o médico de referência
Assinatura	Nome completo, CRM, data e hora da alta

5. CHECKLIST DE ALTA — PREENCHER ANTES DE LIBERAR O PACIENTE

■ Aplicar este checklist em TODA alta hospitalar. Cada item deve ser verificado e marcado antes da liberação do paciente.

■ MÉDICO

☐	Critérios médicos de alta satisfeitos (sinais vitais estáveis, afebril, tolerando VO)
☐	Diagnóstico principal definido e documentado no prontuário
☐	Sumário de alta escrito, completo e assinado com CRM
☐	Exames pendentes identificados e paciente orientado sobre retirada dos resultados
☐	Receituário legível emitido com todos os medicamentos (genérico + dose + frequência + duração)
☐	Reconciliação medicamentosa realizada: verificar o que mudou da admissão para a alta
☐	Medicamentos de alto risco revisados (anticoagulante, insulina, digital, antiarrítmico)
☐	Encaminhamentos / referência ambulatorial realizados ou agendados
☐	AIH e documentação hospitalar preenchidas e entregues
☐	Vacinação verificada e orientações fornecidas

■ ENFERMAGEM

☐	Paciente identificado com nome e data de nascimento antes da alta
☐	Acessos venosos, sondas, drenos retirados ou conduta orientada se permanentes
☐	Pertences pessoais devolvidos ao paciente / acompanhante
☐	Alta de enfermagem registrada no prontuário com horário
☐	Condições do leito e sala comunicadas para limpeza / desinfecção
☐	Cuidador / responsável presente e orientado
☐	Folha de medicamentos entregue ao paciente / acompanhante

■ PACIENTE / CUIDADOR

☐	Paciente (ou cuidador) verbaliza entender o diagnóstico em linguagem simples
☐	Paciente demonstra saber tomar os medicamentos corretamente (o que, quando, como)
☐	Paciente sabe quais são os sinais de alarme para retorno de urgência
☐	Retorno agendado comunicado: data ____/____/____ — Local: _____
☐	Número de contato de emergência fornecido (SAMU 192 / UPA / Hospital)

Alta concedida por: _____ CRM: _____
Data: ____/____/____ Hora da alta: ____:____ Assinatura: _____

Referências: Joint Commission International Accreditation Standards 2023; Kripalani S et al. Arch Intern Med 2007; Coleman EA et al. Care Transitions Interventions. Ann Intern Med 2006.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE TROMBOPROFILAXIA

Escore de Padua • HAS-BLED • TVP/TEP • FA • Anticoagulação

Baseado em: ASH VTE Guidelines 2018 • ACCP Antithrombotic Therapy 2021 • ESC FA Guidelines 2020 • ISTH Guidelines 2022

1. ESCORE DE PADUA — RISCO DE TVP EM PACIENTES CLÍNICOS

Fator de Risco	Pontos
Câncer ativo (metástase / quimio/radio nos últimos 6 meses)	3
TVP/TEP prévio (exceto trombose superficial)	3
Imobilidade ≥ 3 dias (repouso no leito ou mobilidade muito reduzida)	3
Trombofilia conhecida (defic. proteína C ou S, anticoagulante lúpico, SAAF, JAK2, FV Leiden, protrombina G20210A)	3
Trauma e/ou cirurgia recente (≤ 1 mês)	2
Idade ≥ 70 anos	1
Insuficiência cardíaca e/ou insuficiência respiratória	1
IAM ou AVC isquêmico agudo	1
Infecção aguda e/ou doença reumatológica	1
Obesidade (IMC ≥ 30)	1
Tratamento hormonal em curso (ACO, TRH)	1

Pontuação	Risco	Conduta
< 4	BAIXO RISCO	Deambulação precoce + meias de compressão. SEM heparina farmacológica de rotina
≥ 4	ALTO RISCO	Heparina farmacológica (ver abaixo) + meias de compressão elástica. Reavaliar diariamente

2. ESCOLHA DO ANTICOAGULANTE PROFILÁTICO

Situação	Droga de Escolha	Dose	Observações
Paciente clínico geral (Padua ≥ 4)	Enoxaparina (HBPM)	40 mg SC 1x/dia	Aplicar 24h após admissão. Manter durante internação e até deambulação plena

Situação	Droga de Escolha	Dose	Observações
Função renal reduzida (ClCr 15–30 mL/min)	HNF (Heparina não fracionada)	5.000 UI SC 8/8h	HBPM contraindicada se ClCr < 15. Monitorar anti-Xa em casos especiais
Função renal grave (ClCr < 15 ou diálise)	HNF	5.000 UI SC 8/8h	Evitar HBPM. Considerar compressão mecânica associada
Obesidade severa (> 100 kg)	Enoxaparina	40 mg SC 12/12h ou 0,5 mg/kg/dia	Dose padrão pode ser insuficiente. Avaliar nível anti-Xa se disponível
Gravidez	Enoxaparina	40 mg SC 1x/dia (ajustar conforme peso)	HBPM é a 1ª escolha na gestação. Warfarina e DOACs contraindicados
Plaquetopenia ≥ 50.000	Enoxaparina (com cautela)	20 mg SC 1x/dia	Abaixo de 50.000: risco hemorrágico > benefício → compressão mecânica

■ **TROMBOCITOPENIA INDUZIDA POR HEPARINA (TIH):** Plaquetas caem ≥ 50% após 5–10 dias de heparina
→ **SUSPENDER** toda heparina e usar Fondaparinux ou Argatroban

3. ESCORE HAS-BLED — RISCO HEMORRÁGICO EM ANTICOAGULAÇÃO

■ Usar em pacientes candidatos a anticoagulação (especialmente em FA). NÃO é contraindicação à anticoagulação — é para identificar fatores modificáveis.

Letra	Fator	Pontos
H	Hipertensão não controlada (PAS > 160 mmHg)	1
A	Função renal anormal (creatinina > 2,26 ou diálise) e/ou função hepática anormal (cirrose ou bilirrubina 2x + TGO/TGP 3x)	1 (cada)
S	AVC prévio	1
B	Sangramento prévio ou predisposição (úlceras, plaquetas < 100.000, anemia)	1
L	INR lábil (< 60% do tempo na faixa terapêutica) — só para warfarina	1
E	Idoso (≥ 65 anos)	1
D	Drogas (AINEs, AAS, clopidogrel, álcool ≥ 8 doses/semana)	1 (cada)

Pontuação	Risco	Sangramento em 1 ano	Conduta
0–1	BAIXO	~1%	Anticoagular com segurança. Controle de fatores modificáveis
2	MODERADO	~2%	Anticoagular com monitoração rigorosa. Corrigir fatores modificáveis
≥ 3	ALTO	> 3,7%	ALTO RISCO NÃO CONTRAINDICA ANTICOAG se risco trombótico > hemorrágico. Corrigir fatores modificáveis: PAS, AINE, álcool

4. CHA₂DS₂-VASc — RISCO DE AVC EM FIBRILAÇÃO ATRIAL

Letra	Fator	Pontos
C	Insuficiência cardíaca congestiva ou FEVE < 40%	1
H	Hipertensão arterial	1
A■	Idade ≥ 75 anos	2
D	Diabetes mellitus	1
S■	AVC/AIT/tromboembolismo prévio	2
V	Doença vascular (IAM prévio, arteriopatia periférica, placa aórtica)	1
A	Idade 65–74 anos	1
Sc	Sexo feminino (fator modificador, não isolado)	1

Pontuação	Risco AVC/ano	Conduta (homens / mulheres)
0 (homem) / 1 (mulher)	Baixo (< 1%/ano)	Anticoagulação NÃO recomendada rotineiramente
1 (homem) / 2 (mulher)	Intermediário	Anticoagulação deve ser CONSIDERADA (risco/benefício individual)
≥ 2 (homem) / ≥ 3 (mulher)	Alto (> 2%/ano)	Anticoagulação RECOMENDADA salvo contraindicação absoluta

5. ANTICOAGULAÇÃO NA FA — ESCOLHA DO AGENTE

Agente	Dose Padrão (FA)	Indicação Preferencial	Contraindicações
Apixabana (Eliquis)	5 mg 12/12h (2,5 mg 12/12h se ≥2: >80a, <60kg, Cr>1,5)	1ª escolha: menor sangramento GI Idosos, FA não valvar	ClCr < 15; valvopatia mitral reumática; prótese valvar mecânica
Rivaroxabana (Xarelto)	20 mg 1x/dia com jantar	Adesão (1x/dia). FA não valvar	ClCr < 15; gravidez; valvopatia mitral reumática
Dabigatrana (Pradaxa)	150 mg 12/12h (110 mg se > 80 anos ou ↑risco sangramen.)	Menor risco de AVC vs warfarina	ClCr < 30; hepatopatia ativa; prótese valvar mecânica
Warfarina (Varfarina)	Dose ajustada para INR 2–3	Prótese valvar mecânica; valvopatia mitral reumática; ClCr < 15	Gravidez (1T e 3T); alto risco de queda sem compensação
Heparina (HNF EV)	Conforme PTT 60–100s	Hospitalar: FA com reversão prevista; instabilidade; procedimento iminente	Sangramento ativo; TIH

■ DOACs são CONTRAINDICADOS em: prótese valvar mecânica, estenose mitral reumática moderada/grave, gravidez. Usar warfarina nestes casos.

6. TRATAMENTO DE TVP / TEP — SUMÁRIO

Diagnóstico	Droga 1ª escolha	Dose	Duração mínima
TVP proximal ou TEP (1º evento, fator de risco removível)	Rivaroxabana ou Apixabana	Riva: 15mg 12/12h 21d → 20mg 1x/d Apixa: 10mg 12/12h 7d → 5mg 12/12h	3 meses
TVP/TEP recorrente ou idiopático	Anticoagulação estendida (DOAC ou Warfarina)	Mesmas doses de manutenção	≥ 6 meses; reavaliar indefinidamente
TVP/TEP com câncer ativo	Apixabana ou Rivaroxabana (ou Enoxaparina)	Mesmas doses acima Enox: 1 mg/kg 12/12h SC	≥ 6 meses; manter enquanto câncer ativo
TEP maciço com choque	Trombolítico (Alteplase) + Heparina após	Alteplase 100 mg EV em 2h HNF: bolus 60 UI/kg após	Avaliar cirurgia ou trombectomia se contraindicado

Referências: Konstantinides SV et al. 2019 ESC Guidelines on pulmonary embolism; Lip GYH et al. 2020 ESC AF Guidelines; Lim W et al. ASH VTE Guidelines 2021; ISTH Bleeding Risk Scores 2022.

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL — CLÍNICA MÉDICA

FORMULÁRIO DE EVOLUÇÃO MÉDICA DIÁRIA

Modelo SOAP • Medicina Interna • Enfermaria • Uso Diário

■ Imprimir e arquivar no prontuário OU preencher eletronicamente. Uma folha por evolução médica. Assinar com nome legível e CRM.

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:		Prontuário:	
Leito:		Data internação:	/ /
Diagnóstico principal:		DIN:	dias
Data e hora da evolução:	/ / :	Médico:	CRM:

SINAIS VITAIS E PARÂMETROS

PA:	/ mmHg	FC:	bpm	FR:	irp m
Temp:	°C	SpO ₂ :	% em:	Glicemia:	mg/ dL
Peso:	kg	Diurese 24h:	mL	Balanço hídrico:	mL
Dor (0-10):		Glasgow:		Edema:	

S — SUBJETIVO (queixas, sintomas, relato do paciente)

■ O que o paciente relata: melhora ou piora dos sintomas, novos sintomas, dor, apetite, sono, queixas, humor.

O — OBJETIVO (exame físico + exames complementares)

■ Estado geral, exame físico dirigido ao diagnóstico, exames laboratoriais e imagem com resultados e interpretação.

Estado Geral:		Hidratação:	
Pele / mucosas:		Perfusão:	
Cardiovascular:		FC ritmo:	
Pulmonar:		MV/RA/CV:	
Abdominal:		RHA:	
MMII / edema:		Pulsos:	
Neurológico:		Glasgow:	
Outros:		Obs:	

Exames / Resultados:

A — AVALIAÇÃO (diagnósticos, raciocínio clínico, evolução do quadro)

■ Diagnóstico principal atual, diagnósticos secundários ativos, raciocínio clínico, resposta ao tratamento, problemas identificados.

[illegible]

■ Exames solicitados, medicações novas ou modificadas, interconsultas, procedimentos, orientações à enfermagem, previsão de alta, metas do dia.

■ Manter conduta atual	■ Exames solicitados: _____
■ Modificar medicações	■ Interconsulta: _____
■ Novo procedimento	■ Alta prevista para: _____
■ Transferência para UTI	■ Orientações à enfermagem: _____

[illegible]

META TERAPÊUTICA DO DIA

Meta principal para hoje:	—
Previsão de alta:	__/__/__ — Condição para alta:
Prioridade do plantonista:	—

Assinatura: _____ CRM: _____ Data: __/__/__

Hora: ____:____

Santa Casa de Misericórdia de Sobral | Clínica Médica | Dr. Aldenir Rocha – CRM-CE 16587

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE PCR E ACLS NA
ENFERMARIA

Reconhecimento • RCP de Alta Qualidade • DEA/Desfibrilação • Ritmos • Drogas • Pós-PCR

■ LIGUE AGORA para o Código Azul/PCR da instituição. Chame ajuda. Inicie RCP imediatamente. NÃO abandone o paciente.**■ Baseado em: AHA ACLS Guidelines 2020/2023 Update • ILCOR CoSTR 2023 • SBC Diretriz de RCP 2022**

1. RECONHECIMENTO DA PCR — SEQUÊNCIA IMEDIATA

Segundo	Ação	Detalhe
0–10s	Verificar segurança + avaliar vítima	Chamar pelo nome. Estimular ombros. Sem resposta = emergência
10s	Chamar AJUDA + acionar Código Azul	Gritar por socorro. Ligar para código azul. Pedir DEA/carrinho de PCR
10–30s	Verificar pulso + respiração SIMULTANEAMENTE	Pulso carotídeo ≤ 10 segundos. Respiração normal? (gaspings NÃO conta)
< 30s	SE SEM PULSO OU DÚVIDA → INICIAR RCP	NÃO perder tempo. Em caso de dúvida: INICIAR RCP. É mais seguro.
Imediato	Posicionar para RCP	Paciente em decúbito dorsal em superfície RÍGIDA. Baixar grades da cama.

2. RCP DE ALTA QUALIDADE — PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS

Parâmetro	Meta / Detalhe
Frequência das compressões	100–120 por minuto. Contar em voz alta: 1-2-3...30
Profundidade das compressões	5–6 cm (adulto). Deprimir o esterno. NÃO menos de 5 cm.
Retorno total do tórax	Não apoiar o peso no tórax entre compressões. Recuo completo.
Interrupções	Minimizar ao máximo. Pausa máxima de 10 segundos (carga/choque/via aérea)
Relação compressão:ventilação	30:2 sem via aérea avançada. Contínuas (100-120/min) + 10 vent/min com via aérea avançada
Ventilação (bolsa-máscara)	Volume suficiente para elevar o tórax. 1 segundo por ventilação. Evitar hiperventilação
Via aérea avançada	IOT ou máscara laríngea. NÃO interromper RCP > 10s para intubar
Rodízio do compressor	Trocar a cada 2 minutos (ciclo de 5x30:2) para evitar fadiga. QUALIDADE > CONTINUIDADE

Parâmetro	Meta / Detalhe
Capnografia (se disponível)	PETCO2 < 10 mmHg após 20 min = indicador de RCP inadequada ou prognóstico ruim

■ TEMPO DE PRIMEIRO CHOQUE: < 2 minutos do reconhecimento para o 1º choque em FV/TVSP. Meta institucional: < 3 minutos.

3. ALGORITMO POR RITMO — DESFIBRILÁVEL vs NÃO DESFIBRILÁVEL

RITMOS DESFIBRILÁVEIS — FV / TV Sem Pulso

Ciclo	Ação
Ciclo 1	RCP 2 min → Verificar ritmo → FV/TVSP → 1º CHOQUE (bifásico 200J ou máx monofásico 360J) → RCP imediata 2 min
Ciclo 2	Verificar ritmo → FV/TVSP → 2º CHOQUE → RCP 2 min → Adrenalina 1 mg EV (repetir 3/3 min em todos ciclos ímpares)
Ciclo 3	Verificar ritmo → FV/TVSP → 3º CHOQUE → RCP 2 min → Amiodarona 300 mg EV (dose única; 2ª dose 150 mg no ciclo 5)
Ciclos 4+	Repetir sequência: RCP → Verificar → Choque → Adrenalina 3/3 min → Amiodarona 2ª dose no ciclo 5

RITMOS NÃO DESFIBRILÁVEIS — AESP / Assistolia

Ciclo	Ação
Ciclo 1	RCP 2 min contínua → Adrenalina 1 mg EV imediatamente → Verificar ritmo a cada 2 min
Ciclos 2+	RCP 2 min → Adrenalina 1 mg EV a cada 3–5 min → Investigar e tratar causa reversível (Hs e Ts)
Assistolia	NÃO desfibrilar. Excluir "line noise". Confirmar em 2 derivações. Tratar causas reversíveis.
AESP	Atividade elétrica sem pulso: investigar Hs e Ts. USG beira do leito se disponível

4. CAUSAS REVERSÍVEIS DA PCR — Hs e Ts

H/T	Causa	Diagnóstico Beira do Leito	Tratamento
H1	Hipovolemia	Contexto (hemorragia, sepse, diarreia). USG VCI	Cristaloide 1–2L rápido. Transfusão se hemorrágico
H2	Hipoxia	Posição da cânula, expansão, SpO ₂	Ventilar, reposicionar IOT, ventilar com O ₂ 100%
H3	H ⁺ (Acidose)	Gasometria, contexto de acidose grave	Bicarbonato 1 mEq/kg EV se pH < 7,1
H4	Hipo/Hipercalcemia	ECG (onda T apiculada, QRS alargado). K ⁺ sérico	Gluconato Ca 10% EV. Bicarbonato. Insulina/Glicose
H5	Hipotermia	Temperatura central. Contexto	Reaquecimento ativo. RCP prolongada
T1	Tensão pneumotórax	Desvio de traqueia, ausência de MV unilateral	Toracocentese de alívio imediata (2º EIC LMC)
T2	Tamponamento cardíaco	USG beira do leito (derrame + colapso de VD)	Pericardiocentese de emergência
T3	Trombose (coronária / TEP)	Contexto. ECG (ST). USG (cor pulmonale agudo)	IAM: cath urgente. TEP: trombolítico durante RCP
T4	Tóxicos / Overdose	Contexto. QRS alargado, QT longo	Bicarbonato (ADT). Naloxona (opioides). Específico

5. DROGAS NA PCR — DOSES E INDICAÇÕES

Droga	Dose	Via	Indicação / Observação
Adrenalina (Epinefrina)	1 mg EV Repetir 3–5 min	EV ou IO (preferir central)	TODOS os ritmos. Vasopressor + efeito cronotrópico. NÃO interromper RCP para dar
Amiodarona	300 mg EV (1ª) 150 mg EV (2ª)	EV ou IO em bolus diluído em 20mL SG	FV/TVSP refratária (após 3º choque). Diluir em SG 5% se via periférica
Lidocaína (alternativa)	1–1,5 mg/kg EV 0,5–0,75 mg/kg (2ª)	EV ou IO	Alternativa à amiodarona na FV/TVSP. Máx 3 mg/kg total
Bicarbonato de sódio 8,4%	1 mEq/kg EV (50 mL = 50 mEq)	EV em bolus	Hipercalemia grave, acidose severa (pH<7,1), intox. ADT. NÃO rotineiro
Sulfato de Magnésio	1–2 g EV em 5 min	EV em bolus	Torsades de pointes, FV refratária associada a hipomagnesemia
Atropina	NÃO usar na PCR	—	Sem benefício em assistolia/AESP. Pode ser usada em bradicardia com pulso
Gluconato de Cálcio 10%	10 mL EV (1 ampola)	EV lento	Hipercalemia grave, hipocalcemia, intox. por BCC
Naloxona	0,4–2 mg EV/IM	EV, IM ou intranasal	Overdose de opioide. Efeito dura 30–90 min; repetir se necessário

6. CUIDADOS PÓS-PCR — SÍNDROME PÓS-PARADA CARDÍACA

Domínio	Meta	Conduta
Oxigenação	SpO ₂ 94–98% PaO ₂ 60–100 mmHg	Evitar hiperoxia (FiO ₂ mínima para atingir meta). Gasometria de controle
Ventilação	PaCO ₂ 35–45 mmHg (normocapnia)	Evitar hiperventilação. PETCO ₂ alvo 35–40. FR 10-12/min em VM
Hemodinâmica	PAM ≥ 65–70 mmHg PAS ≥ 90 mmHg	Noradrenalina se necessário. Dobutamina se baixo débito. Ecocardiograma precoce
Temperatura-alvo	Controle térmico 32–37,5°C por 24–48h	EVITAR febre (> 37,5°C) nas primeiras 72h. Tratamento ativo se indicado
Glicemia	140–180 mg/dL	Insulinoterapia. EVITAR hipoglicemia (< 70). Dosar 1/1h inicialmente
Neurológico	Prognóstico ≥ 72h	TC crânio precoce. EEG se crise suspeita. Não progredir prognóstico < 72h
Cardiológico	Identificar causa	ECG 12D imediato. Cateterismo se suspeita de SCA. Enzimas cardíacas seriadas
UTI	Admissão imediata	TODO sobrevivente de PCR → UTI. Monitoração contínua 24–48h mínimo

7. REGISTRO DA PCR — FICHA DE REGISTRO

■ Registrar **TODOS** os dados em tempo real durante a PCR. Delegar anotador no início do atendimento. Documentar no prontuário imediatamente após.

Hora da PCR reconhecida:	____:____	Ritmo inicial:	_____
Hora 1ª compressão:	____:____	Causa suspeita:	_____
Hora 1º choque:	____:____	Hora 1ª adrenalina:	____:____
Hora IOT:	____:____	Hora amiodarona:	____:____
Hora RCE (retorno circulação):	____:____	Tempo total de RCP:	_____ min
Hora suspensão:	____:____	Desfecho:	RCE / Óbito
Compressor 1:	_____ _____	Compressor 2:	_____ _____
Médico responsável:	_____ _____	CRM:	_____

Referências: AHA ACLS Guidelines 2020; Panchal AR et al. Circulation 2020; ILCOR CoSTR 2023; SBC – Diretriz de RCP e Emergências Cardiovasculares 2022.